BC3 – Chapitre 7 : tout ce qu'il faut savoir

Démarche de projet (1) : diagnostic, priorités et objectifs – fiche complète (à jour au 1er novembre 2026)

Mode d'emploi

Cette fiche résume tout le chapitre 7 : le projet de santé publique et son cycle ; l'analyse de situation ; le recueil de données (questionnaire, entretien, groupe de parole, observation) ; l'analyse et la présentation des données ; le diagnostic (arbre à problèmes, FFOM) ; les priorités (Hanlon, PEARL) ; les objectifs SMART et les indicateurs ; l'échantillonnage ; les méthodes participatives ; l'environnement alimentaire ; les tableaux croisés ; la problématique ; la FFOM croisée ; le fil rouge d'Inès ; les approfondissements, le cas guidé et les méthodes d'épreuve. Elle suit l'ordre du cours (7.3.1 à 7.9).

Corrections du fascicule CNED (Environnement professionnel, Les essentiels, 2e année, © 2022) à appliquer :

- **Stratégie nationale de santé** : le fascicule cite la SNS 2018-2022. Elle est **terminée**, et la SNS 2023-2033 n'était **pas adoptée** en mai 2026. Pour justifier une priorité nutritionnelle, on cite le **PNNS 5 (2026-2030)**, lancé le **8 avril 2026**, et la **SNANC 2025-2030** (stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat).
- **Sigles** : la conférence régionale est la **CRSA** (conférence régionale de la santé et de l'autonomie), pas la « CRAS » ; le **HCSP** (Haut Conseil de la santé publique) existe depuis **2004** ; il n'existe pas de « CNSP » : l'instance nationale de démocratie sanitaire est la **CNS** (Conférence nationale de santé).
- **Champ de forces** : forces « **motrices** » (favorables), et non « matrices ».
- **AFOM = FFOM = SWOT** : un seul outil, trois sigles.
- **Études nationales** : **INCA 3 (2014-2015)** et **Esteban (2014-2016)** restent les dernières publiées. **Albane** a lancé son premier cycle en **juin 2025** (plus de 3 000 personnes) ; le recueil finit **fin 2026**, premiers résultats attendus **début 2028**.
- **Annales** : les documents qui citaient le PNNS 4 (2019-2023) citent maintenant le **PNNS 5**.

Autres mises à jour :

- **Repas à 1 € au Crous** : l'étude de cas du cours le réserve aux boursiers et aux étudiants précaires. Depuis le **4 mai 2026**, il est **ouvert à tous les étudiants** (info.gouv.fr, 2026). Le diagnostic d'un campus doit donc vérifier si les étudiants le **connaissent** et peuvent **y accéder** (horaires, distance), plutôt que son prix.
- **Quartiers prioritaires (QPV)** : liste **révisée au 1er janvier 2024** (environ 1 580 quartiers, métropole et outre-mer). Les contrats de ville « Engagements Quartiers 2030 » couvrent 2024-2030. Une donnée QPV antérieure à 2024 peut porter sur un périmètre différent.
- **Repères nationaux utiles** : taux de pauvreté **15,4 % en 2023** (Insee, 2025) ; adultes en surpoids **49 %** dont obésité **17 %** (Esteban 2015) ; enfants de 6-17 ans en surpoids **17 %** dont obésité **4 %** (Esteban 2015).

Ce qui est en **gras** est à savoir par cœur. Toutes les données des exemples sont **fictives**, sauf les repères nationaux sourcés.

1. Le projet de santé publique (7.3.1)

Projet : ensemble **coordonné** d'actions, **limité dans le temps**, doté de **moyens définis**, conduit par une équipe pour atteindre des **objectifs précis** en réponse à un **besoin identifié**. En santé publique, il vise **la santé d'une population**, pas d'un individu. **Afnor** (repris par le CNED) : « processus unique… activités coordonnées et maîtrisées… date de début et date de fin… contraintes de délais, de coûts et de ressources ».

Du plus large au plus précis : **politique** (PNNS 5, PRS) > **programme** (programme régional nutrition) > **projet** (« Bien manger, petit budget, grand plaisir ») > **action** (un cycle de 6 ateliers) > **séance** (l'atelier n° 3 du 28 mars). Un **atelier** est une forme possible de l'action.

Le cycle de projet en 7 étapes (fiches du dossier) :

Étape	Contenu	Fiche
1. **Analyse de situation**	territoire, public, problèmes, ressources, politiques	F1
2. **Diagnostic et priorités**	problème central, causes, conséquences ; choisir sur quoi agir	F2

Étape	Contenu	Fiche
3. **Objectifs**	hiérarchisés et mesurables	F3
4. **Plan d'action**	actions, partenaires, calendrier, budget (chapitre 8)	F4-F6
5. **Mise en œuvre**	animer, communiquer, piloter	F7-F10
6. **Évaluation**	ce qui a été fait, ce qui a changé (chapitre 9)	F11-F12
7. **Valorisation et ajustements**	diffuser, pérenniser, améliorer	F13-F14

Au **centre** : **participation, partenariat, éthique**. La démarche est **cyclique** : l'évaluation nourrit un nouveau diagnostic.

Trois erreurs fréquentes : **commencer par l'action** ; **confondre objectif et action** (« animer 6 ateliers » = opérationnel) ; **oublier l'évaluation** dès la conception (pas d'indicateurs ni d'état initial).

Cadres de référence :

Cadre	Principe
Pineault et Daveluy (1986, rééd. 1995)	besoins → priorités → objectifs → actions → mise en œuvre → évaluation
PRECEDE-PROCEED (**Green et Kreuter**)	raisonner **à rebours** : qualité de vie → santé → comportements et environnement → facteurs → intervention
Cadre logique	matrice objectifs, résultats, activités, indicateurs, sources, hypothèses (financeurs)
Guide d'autoévaluation **INPES 2009**	questions sur chaque étape pour améliorer la qualité
Outil de catégorisation des résultats (**Promotion Santé Suisse**)	résultats sur les offres, capacités, environnements, compétences, santé

Les 3 facteurs de PRECEDE : **prédisposants** (connaissances, attitudes, croyances) · **facilitants** (compétences, accès, prix, ressources : « savoir cuisiner les légumes secs ») · **de renforcement** (soutien de l'entourage, valorisation). Intérêt : ne pas se limiter à l'information.

Repères CNED : **appel à projets** (cahier des charges, budget, date limite ; chapitre 8) ; **parties prenantes** (équipe, partenaires, usagers, financeurs et décideurs) ; **démarche d'étude** ≠ démarche de projet, avec données **« froides »** (statistiques, rapports) et **« chaudes »** (questionnaires, entretiens, observations) ; outils de l'état des lieux : **remue-méninges, QQOQCP, Ishikawa, champ de forces, arbre à problèmes, carte mentale, FFOM** ; **communiquer, valoriser, capitaliser** tout au long du projet.

Qui fait quoi : **porteur** (structure responsable, signe, rend des comptes) · **chef de projet** (organise, calendrier, budget) · **comité de pilotage = décide** (valide diagnostic, priorités, objectifs, budget) · **comité technique = prépare** (outils, analyses, options) · partenaires opérationnels · financeurs (posent des conditions) · **public** (participe aux décisions) · personnes ressources. Le diététicien traduit les repères en actions concrètes, mais ne décide ni du politique ni du financement.

Rétroplanning : partir de la date de validation et remonter le temps ; 8 semaines type (découverte → entretiens et questionnaire → prétest → passation → analyse → restitution et priorisation → objectifs → rédaction). **3 règles** : **marge d'environ 20 %** ; fixer les réunions de validation **dès la semaine 1** ; distinguer tâches **parallèles** et **successives**. Exemple : 8 × 35 = 280 h, tâches 225 h → marge 55 h = **19,6 %** ; une semaine de retard → 20 h = 7,1 %. Présentation en **diagramme de Gantt** (barres + losanges pour les jalons).

2. L'analyse de situation (7.3.2)

Les 4 besoins de Bradshaw (1972) :

Besoin	Qui le définit	Exemple
Normatif	experts, par rapport à une **norme**	27 % des familles atteignent le repère « légumes secs 2 fois/semaine »
Ressenti	les personnes (**perçu**)	« je ne sais pas cuisiner les lentilles »
Exprimé	ressenti traduit en **demande**	26 parents demandent des ateliers ; liste d'attente

Besoin	Qui le définit	Exemple
Comparatif	**écart** avec une référence	14 % d'enfants en surpoids contre 9 % dans le département

Triangulation : un besoin confirmé par plusieurs types est plus solide. Normatif non ressenti → sensibiliser et écouter ; ressenti non normatif → à entendre (convivialité). On ajoute les besoins **ressentis par les professionnels** et les besoins **observés** par l'étudiant.

Les 8 rubriques (grille O7.1) : **territoire** (Insee, sig.ville.gouv.fr) · **population** (recensement, Filosofi, CAF) · **état de santé** (Géodes, ORS, Data pathologies, santé scolaire, PMI) · **comportements** (INCA 3, Esteban, Albane ; enquête locale) · **offre et environnement** (repérage, relevé de prix) · **ressources et acteurs** · **politiques et financements** (PNNS 5 / SNANC, PRS, CLS, PAT, contrat de ville, appels à projets) · **besoins et attentes**. La colonne **« ce qui me manque »** justifie chaque outil de recueil.

Citer une donnée : **source + année + champ** (âge, territoire). « 9 % des enfants de grande section sont en surpoids (santé scolaire, bilans 2025-2026). » Distinguer données **nationales** (contexte), **locales** (justification) et **recueillies** (enquête).

Indicateurs de territoire : structure par âge (donner l'année du recensement) ; **taux de pauvreté** = part des personnes sous **60 % du niveau de vie médian** (≠ allocataires de minima sociaux) ; familles monoparentales (sur les familles avec enfants, pas les ménages) ; habitants en QPV (ne pas généraliser à la commune) ; prévalence du surpoids (comparer les mêmes âges).

Calculs de base : prévalence = 380 / 5 000 = **7,6 %** ; incidence = 46 / 5 000 × 1 000 = **9,2 pour 1 000** et par an. **3 règles de comparaison** : même **référence** (année, âge) ; **taux standardisés** pour comparer des territoires d'âges différents ; prudence sur les **petits nombres** (et secret statistique).

Exemple Ormeaux (7 350 hab.) : moins de 20 ans 1 911 / 7 350 = **26,0 %** contre 22,4 % (rapport **1,16**) ; 75 ans et plus 11,5 % contre 9,8 % (1,17) ; personnes seules 39,6 % contre 37,1 % (1,07). **Valdrôme** : 60-74 ans 21,0 % (1,14) ; 75 ans et plus 13,0 % (1,25) ; ménages d'une personne 44,0 % (1,16) → piste : isolement des personnes âgées au moment des repas.

Parcours de recherche en 6 étapes : politiques et diagnostics existants (CLS, ORS) → Insee → Géodes / Data pathologies → données de la structure → partenaires (santé scolaire, PMI) → noter ce qui manque.

3. Recueillir des données sur le terrain (7.3.3)

Méthode	Pour quoi	Limite
Questionnaire	fréquences, comparaisons chiffrées	déclaratif ; littératie
Entretien semi-directif	comprendre les raisons, l'avis des pros	long, peu de personnes
Groupe de parole (focus group, **6 à 10 personnes**, **60-90 min**)	représentations, débat	**effet de groupe**
Observation (grille)	ce qui se fait réellement	**effet observateur**
Relevé de l'offre	prix, commerces	une date, une saison
Analyse documentaire	données existantes	ancienneté

Questionnaire en 8 étapes : **objectif → variables → types de questions → rédaction → ordre → mention RGPD → prétest → grille d'analyse**. **Prétest** auprès de **3 à 5 personnes du public** (pas des collègues) ; **10 minutes maximum**.

Erreurs de rédaction : question **double** (« fruits et légumes et produits laitiers ») ; **orientée** (« Ne pensez-vous pas que… ») ; modalités qui **se chevauchent** (1-3 / 3-5) ou **non exhaustives** ; termes **techniques** ; **période floue** (préférer « hier », « la semaine dernière »).

5 biais : **sélection** (qui répond n'est pas toute la population) · **non-réponse** · **désirabilité sociale** (surdéclarer les fruits, sous-déclarer les sodas) · **mémoire** · **enquêteur**.

Marge d'erreur à 95 % : **$e = 1{,}96 \times \sqrt{p(1-p)/n}$**. Inès : 34 / 48 = 70,8 % ; 0,708 × 0,292 = 0,2067 ; / 48 = 0,004307 ; √ = 0,0656 ; × 1,96 = **± 12,9 points** → IC **57,9 % – 83,7 %**. **Taille** : $n = 1{,}96^2 \times p(1-p) / e^2$ → **385** pour ± 5 points, **151** pour ± 8, **97** pour ± 10 (p = 0,5). **Sous 20 répondants : donner les effectifs** (« 12 parents sur 20 »).

Entretien en 5 temps : **présenter** (but, anonymat, durée) → **ouvrir** → **approfondir** (relances) → **vérifier** (reformuler) → **conclure**. Grille de **4 à 6 thèmes** ; noter des **verbatims**. Exemple : 9 entretiens, le prix cité 7 fois sur 9 (on écrit

l'effectif).

Mesurer les consommations : rappel, fréquence, observation, **pesée des restes**. **Taux de restes = restes / servi × 100** (exemple : légumes **41,0 %**, fruit 40,0 %, global 31,2 %).

Observation : grille précise, plusieurs jours ; **accord inter-observateurs** 34 / 40 = **85 %** (seuil d'environ **80 %**).

Questionnaire accessible (6 règles) : phrases courtes, une idée ; pictogrammes ; échelles visuelles ; version **orale** ou avec **médiatrice** ; traduction ; test auprès du public (chapitre 5).

Taux de réponse = réponses / distribués × 100 (école 34,7 %, PMI 72 %, épicerie 77,5 %, global 47 %).
Représentativité : comparer la structure des répondants à celle de la population (ratio 0,65 pour les 60 ans et plus = sous-représentés ; 1,41 pour les familles monoparentales = surreprésentées).

4. Analyser et présenter les données (7.3.4)

Calcul	Formule	Exemple
Pourcentage	n / total × 100	34 / 48 = 70,8 %
Écart en points	p1 − p2	14 − 9 = 5 points
Rapport	p1 / p2	14 / 9 = 1,56
Variation relative	(final − initial) / initial × 100	25 → 60 % = **+ 140 %** (et + 35 points)
Moyenne	somme / n	sensible aux valeurs extrêmes
Médiane	valeur du milieu des données classées	résiste aux extrêmes

Dépouillement : **numéroter** les questionnaires → **coder** (9 = non-réponse) → **saisir** (une ligne par questionnaire) → **contrôler 1 sur 10** → traiter les non-réponses (dire le n réel, ex. n = 45). Variables **qualitatives** (pourcentages) ≠ **quantitatives** (moyenne, médiane). **Ne jamais faire la moyenne de codes.**

Exemples : jours avec fruit : moyenne **3,3**, médiane **3**, au moins 5 jours **29,2 %**. Budget de 12 familles : moyenne **32,6 €**, médiane **30,5 €**, Q1 25,5, Q3 36,5, **écart interquartile 11**, étendue 46.

Choisir un graphique : **barres** pour comparer des catégories ; **secteurs** seulement pour des parts d'un tout (une seule réponse) ; **courbe** pour une évolution. **Mentions obligatoires** : titre, **n**, source et date, unité, interprétation.
Graphiques honnêtes : pas d'**axe tronqué** (52 contre 56 paraît 3 fois plus grand au lieu de 1,08) ; **pas de camembert pour des réponses multiples** (total 187,5 %) ; **pas de 3D**.

Analyse thématique (qualitatif) : relire, découper en thèmes, compter combien de personnes citent chaque thème, garder un verbatim représentatif.

5. Poser le diagnostic (7.3.5)

Problème central : situation **négative, observable, mesurable**, qui concerne le public. **Jamais une solution déguisée** (« manque d'ateliers »). Exemple : « L'alimentation des familles du quartier est peu diversifiée. »

Arbre à problèmes : **tronc** = problème central ; **racines** = **causes** (chacune appuyée par un **fait** du diagnostic ; les hypothèses non vérifiées en **pointillés**) ; **branches** = **conséquences**. Remonter les causes en demandant **« pourquoi ? » trois fois** (exemple : les jeunes du FJT sautent le dîner → ils rentrent tard → la cuisine collective ferme après 21 h).

Familles de causes : PRECEDE (prédisposantes, facilitantes, de renforcement) + **environnement** (offre, prix, organisation). **4 questions de vérification** : chaque cause repose-t-elle sur un fait ? Les causes sont-elles de plusieurs familles ? Le lien cause → problème est-il logique ? A-t-on évité de **blâmer le public** ?

FFOM : **forces et faiblesses = internes** à la structure ; **opportunités et menaces = externes**. Une caractéristique du public n'est pas une faiblesse ; une action future n'est pas une opportunité.

Triangulation : un même constat par plusieurs sources (légumes secs : questionnaire, groupe de parole, PMI, relevé de l'offre).

Restitution du diagnostic (avant de décider les priorités) : **3 fonctions** (**valider** les résultats, **corriger** l'arbre, **mobiliser**). Formats selon le public (affiche et échange pour les habitants, note d'une page pour les décideurs) ; 6 étapes (préparer, présenter, faire réagir, noter, ajuster, remercier).

6. Définir les priorités (7.3.6)

7 critères : ampleur, gravité, efficacité des actions possibles, faisabilité, demande du public, **cohérence politique** (PNNS 5, PRS, CLS), **équité**.

Méthode de Hanlon : A = **ampleur**, B = **gravité**, C = **efficacité** (0 à 10). **Score = (A + 2B) × C / 3** (la gravité compte double ; maximum **100**). Puis **test PEARL** : **P**ertinence, **É**conomie, **A**cceptabilité, **R**essources, **L**égalité ; 1 = oui, 0 = non ; **un seul 0 écarte le problème**.

Tilleuls	A	B	C	Score	PEARL
P1 Légumes et légumes secs	7	6	7	(7 + 12) × 7 / 3 = **44,3**	retenu
P2 Boissons sucrées des enfants	5	7	6	114 / 3 = **38,0**	retenu
P3 Allaitement court	3	6	4	20,0	R = 0 (PMI) → orientation
P4 Sédentarité	6	5	3	16,0	R = 0 → CLS (plaidoyer)

Notes **subjectives** : on les attribue **en groupe** et on les **justifie par des faits**. En groupe, on fait la **moyenne des notes** (MSP : P1 44,0 ; P2 39,7 ; P3 33,3).

Grille pondérée : fixer les **poids avant de noter** ; exemple lycée 36 / 50 = 72 %, puis 35 et 31. **Croiser** Hanlon avec le **groupe nominal** (avis du public).

7. Rédiger les objectifs (7.3.7)

Niveau	Ce qu'il décrit	Exemple
Général	but à long terme auquel le projet **contribue**	« Contribuer à améliorer la diversité de l'alimentation des familles »
Spécifique	**changement chez le public**, SMART, un par cause retenue	« D'ici fin mai, au moins 60 % des familles participantes consomment des légumes secs 2 fois par semaine »
Opérationnel	**ce que fait l'équipe**, SMART	« Animer 6 ateliers de mars à mai »

Lire de haut en bas : **comment ?** ; de bas en haut : **pourquoi ?**. L'**arbre à objectifs** transforme chaque cause de l'arbre à problèmes en objectif positif.

SMART : **S**pécifique, **M**esurable, **A**tteignable, **R**éaliste (pertinent), **T**emporellement défini. **Verbes observables** (Bloom 1956, révisée par **Anderson et Krathwohl 2001**) : citer, choisir, cuisiner, comparer, préparer. **À éviter** : sensibiliser, prendre conscience, comprendre.

Calculs : 25 % → 60 % de 12 familles : 0,60 × 12 = 7,2 → **8 familles** (arrondi **au supérieur**) ; + 35 points, + 140 %. 6 ateliers × 12 = 72 présences ; 80 % = 57,6 → **58**.

Indicateurs : d'**impact** (santé, long terme), de **résultat** (changement chez le public), de **processus** (ce qui a été fait). Qualités : **valide, fiable, sensible, disponible, compréhensible**. Fiche indicateur : définition, calcul, source, valeur initiale, cible, date. **Valeur cible réaliste** : valeur initiale, données publiées, durée et intensité, **perdus de vue** (27 sur 36 restent = 75 %).

8. Choisir un échantillon (7.3.8)

Méthode	Principe	Exemple
Aléatoire simple	tirage au sort dans la **base de sondage** (ALEA du tableur)	40 élèves sur une liste
Systématique	**pas k = N / n**, départ tiré au hasard	280 / 40 = 7 : un sur 7
Stratifié	tirage dans chaque strate selon son poids	collège 520 → 130 (35 + 33 + 32 + 30)
Grappes	tirer des groupes entiers	10 classes, tous les élèves

Méthode	Principe	Exemple
Quotas	respecter la répartition connue	54 % de femmes sur 150 = 81
Convenance	personnes disponibles	sortie d'école : **biais de sélection**

Petite population (N) : **n' = n / (1 + (n − 1) / N)**. Pour ± 5 / ± 10 points : N = 180 → **123 / 64** ; 520 → 222 / 82 ; 1 200 → 292 / 90 ; 20 000 → 378 / 97. Exemple : 300 familles → 385 / 2,28 = **169**. Si la population est petite, on fait une **enquête exhaustive**.

Refus et absents : les noter (120 tirés, 97 répondants = **80,8 %**) ; ne pas remplacer au hasard par des volontaires.

9. Les méthodes participatives (7.3.9)

Photolangage (choisir des photos pour s'exprimer) · **photovoice** (Wang et Burris 1997 : les habitants photographient ce qui aide ou empêche de bien manger, puis commentent) · **marche exploratoire** (parcours du quartier avec une grille : supérette 3,0 / 4, marché 1,7 / 4 pour l'accès) · **cartographie participative** · **world café** · **arbre à problèmes collectif**.

Groupe nominal (**Delbecq et Van de Ven, 1971**) en 6 étapes : question → **réflexion individuelle silencieuse** → tour de table → clarification → **vote pondéré 5-4-3-2-1** → résultat. **Total = participants × 15** : 8 × 15 = **120** ; coût des fruits et légumes 31 points = **25,8 %**.

Niveaux de participation : consultation (on demande l'avis) < concertation (on discute) < **coconstruction** (on décide ensemble). Éviter la **participation alibi** (avis demandé mais jamais pris en compte).

10. L'environnement alimentaire (7.3.10)

Indicateurs : densité de commerces (pour 1 000 habitants), distance au point de vente de produits frais, restauration rapide autour des écoles (500 m), accès à l'aide alimentaire. **Indice d'environnement favorable** (inspiré du **mRFEI, CDC 2011**) = **favorables / (favorables + défavorables) × 100**.

Tilleuls (800 m) : 2 / (2 + 5) × 100 = **28,6 / 100** ; densité 7 / 4 200 × 1 000 = **1,67 pour 1 000** ; ratio restauration rapide / produits frais = 3 / 2 = 1,5.

Désert alimentaire = accès difficile aux produits frais et abordables (éloignement, transports). **Marais alimentaire** = offre **abondante mais dominée par l'offre défavorable**.

Panier de référence (8 à 15 produits, mêmes formats, 3 à 5 commerces, même semaine, daté) : supérette **17,45 €**, supermarché 13,19 € (**− 24,4 %**), marché 12,90 € (**− 26,1 %**) ; surcoût annuel (17,45 − 12,90) × 52 = **236,60 €**. Limites : promotions, qualité, quantités achetées.

Hunger Vital Sign (**Hager et coll., Pediatrics, 2010**) : **2 questions** sur les 12 derniers mois ; « souvent » ou « parfois vrai » = risque d'insécurité alimentaire. PMI : 23 / 64 = **35,9 %** (repérage local, non généralisable). Traduction libre : outil de repérage, pas d'estimation nationale. Repère national : environ **11 %** des adultes en insécurité alimentaire pour raisons financières (INCA 3, 2014-2015).

11. Croiser les données (7.3.11)

Tableau croisé : pourcentages **dans le sens des groupes comparés** (en ligne). Inscrites à l'épicerie 9 / 30 = **30,0 %** contre non-inscrites 4 / 18 = **22,2 %** : écart 7,8 points, rapport 1,35 → **tendance à vérifier** (marges > 15 points).

Facteur de confusion : troisième variable liée aux deux autres, qui **crée ou modifie** l'association. On la repère par la **stratification** (recalculer dans chaque groupe). Ateliers et fruits : 52,0 % contre 30,9 % (rapport 1,68) au total, mais **1,09 et 1,17** dans chaque groupe : la différence vient du **temps disponible** (ateliers le mardi à 14 h). Cantine et petit-déjeuner : rapport **1,00** dans chaque groupe → la cause est l'organisation du matin.

Méthode : quel facteur explique A et B ? → séparer → recalculer → comparer → écrire **« association observée », « tendance »**, jamais « les ateliers ont permis ». Petits groupes après stratification : donner les effectifs.

12. Problématique et chaîne logique (7.3.12)

Problématique en 4 étapes : constat central → **tension ou paradoxe** (« veulent mieux manger mais pensent que c'est cher ») → **public, lieu, levier** → **question ouverte** (« Comment… ? », « En quoi… ? »).

Insuffisant	Pourquoi
« Les familles mangent-elles mal ? »	fermée, jugeante
« Comment lutter contre l'obésité ? »	trop vaste, centrée sur le poids
« Pourquoi faire des ateliers cuisine ? »	part de la solution

Problème central (décrit une situation) → **problématique** (pose la question) → **objectif général** (énonce le but) : les trois doivent être **cohérents**.

Tableau de cohérence (4 colonnes) : **constat (source) | cause retenue | objectif spécifique | indicateur et valeur initiale**. **4 contrôles** : lire chaque ligne (la cause explique-t-elle le constat ? l'objectif agit-il sur la cause ? l'indicateur mesure-t-il l'objectif ?) ; **même public** ; chiffres et valeur initiale cohérents ; **aucun manque** (chaque cause a un objectif, chaque opérationnel sert un spécifique).

Chaîne cassée (EHPAD) : constat 18 résidents sur 62 ont perdu plus de 5 % de leur poids ; objectif « former 10 soignants » = **opérationnel**, indicateur de **processus**. Réparation : « D'ici 3 mois, au moins 70 % des résidents concernés consomment au moins la moitié de leur collation enrichie. »

13. La matrice FFOM croisée (7.3.13)

Croisement	Stratégie	Idée
Forces × opportunités	**offensive**	utiliser ses atouts pour saisir les occasions
Faiblesses × opportunités	**amélioration**	profiter des occasions pour corriger ses faiblesses
Forces × menaces	**défensive**	utiliser ses atouts pour réduire les menaces
Faiblesses × menaces	**survie**	réduire la vulnérabilité

Aussi appelée **TOWS**. Méthode : 3 à 5 éléments précis par case (« cuisine pédagogique de 6 postes », pas « bons locaux ») → croiser → trier (priorités, faisabilité) → transférer au **plan d'action (chapitre 8)**. Exemple aide à domicile : la stratégie défensive repère la perte d'appétit **sans peser** ceux qui refusent (autonomie).

14. Fil rouge : le diagnostic d'Inès (7.3.14 et 7.3.15)

Calendrier en 10 jours : découverte et données (J1-J2) → repérage et relevé de prix de 15 produits (J3) → 3 entretiens de 30 min (J4) → questionnaire de 14 questions, prétest auprès de 4 mamans (J5) → **48 questionnaires** dont 11 à l'oral et 6 avec médiatrice (J6-J7) → groupe de parole de 8 parents (J8) → saisie et analyse (J9) → arbre, Hanlon, restitution (J10).

Relevé de prix : carottes − 33,3 % au marché ; une portion de lentilles (60 g) coûte **0,22 €** au marché contre **1,10 €** pour 100 g de steak haché → contredit « équilibré = cher » ; mais le marché est à 2,5 km → visite accompagnée.

Groupe de parole : coût des fruits et légumes 7 / 8 ; manque de temps 6 ; refus des enfants 6 ; méconnaissance des légumes secs 5 ; **envie de cuisiner ensemble 5 / 8** → méthode collective.

Causes non retenues : revenus (→ plaidoyer CCAS, commune), offre commerciale (→ PAT, CLS), sédentarité (→ club sportif). **Hiérarchie** : 1 général, 4 spécifiques, 2 opérationnels. **Problématique** : « Comment aider les familles des Tilleuls, qui associent alimentation équilibrée et coût élevé, à intégrer davantage de légumes et de légumes secs à leurs repas, avec leur budget et leurs habitudes culturelles ? » **Stratégie** : offensive (appel à projets ARS + cuisine + épicerie) ; amélioration (balance, ustensiles) ; défensive (recettes à moins de 1,50 €) ; survie (2 mamans relais).

Plan de la partie diagnostic (3 à 5 pages) : **structure** (½ p.) → **contexte** (2 à 4 chiffres sourcés, politiques ; 1 p.) → **méthode** et limites (½ p.) → **résultats** par type de besoin (1 à 2 p.) → **synthèse** : problème, arbre, priorités, causes retenues ou non (1 p.) → **objectifs** et indicateurs (½ p.). Outils en **annexe**. Auto-vérification en 10 points (source et date, n, limites, SMART…).

15. Approfondissements (7.4)

- **Contrat local de santé (CLS)** : **art. L. 1434-10 CSP**, signé entre l'**ARS** et une **collectivité** pour décliner le PRS ; s'appuie sur un **diagnostic local de santé** (souvent ORS). **4 lectures** : méthode (qui, quand ; plus de 5 ans →

compléter), synthèse, indicateurs utiles (page et année), **fiches-actions**. **Recopier n'est pas diagnostiquer** : il faut un recueil propre. Rencontrer le coordinateur du CLS (30 min).

- **Diagnostic partagé** : habitants associés au choix des questions, au recueil, à l'interprétation → appropriation, **pouvoir d'agir**.
- **Données probantes** : **portail des interventions probantes ou prometteuses** de Santé publique France. Vérifier **efficacité** et **transférabilité** (public, environnement, intervenants, durée et intensité, partenariats ; outil ASTAIRE au chapitre 9). Garder les **fonctions clés** (exposition répétée), adapter la forme. Citer le programme, la source et l'année.
- **Selon le milieu** : école (chef d'établissement, infirmière, **CESCE**, données agrégées) ; entreprise (**anonymat strict**, **service de prévention et de santé au travail**, passations la nuit pour les équipes postées) ; EHPAD (**CVS**, données agrégées, consentement) ; quartier (ne pas stigmatiser, restituer) ; rural (distances) ; aide alimentaire (dignité, **ne jamais conditionner l'aide**). Données **individuelles jamais** dans le dossier.
- **Inégalités** : comparer deux groupes (18,5 % contre 11,2 % : 7,3 points, rapport 1,65) ; montrer un **gradient** (3 groupes ou plus : 28 %, 45 %, 66 % selon le diplôme) ; prévoir un **indicateur d'équité** (26 / 40 = 65 % de participants du QPV pour 32 % de la population : rapport **2,03**, objectif atteint ; < 1 = le projet creuse les écarts). **Universalisme proportionné** (Marmot 2010). Statut social mesuré avec respect (diplôme, emploi, C2S, **score EPICES**).

16. Pour aller plus loin – niveau L3 (7.5)

- **Cadre logique** : lignes (objectif général, spécifiques, résultats, activités) × colonnes (description, **indicateurs objectivement vérifiables**, **sources de vérification**, **hypothèses**). **Théorie du changement** : chaîne « **si… alors… à condition que…** ».
- **Inférence** : la marge d'erreur n'est valide que pour un **tirage aléatoire** ; convenance et quotas → approximation.
- **Khi-deux** : effectifs attendus = total ligne × total colonne / total ; $\chi^2 = \Sigma$ (observé − attendu)² / attendu. Exemple épicerie : **0,345 < 3,84** (1 ddl, 5 %) → **non significatif**. Effectif attendu < 5 → **test exact de Fisher**.
- **Méthode Delphi** : panel d'experts, tours de questionnaires **anonymes** avec synthèse, jusqu'au **consensus**.

17. Le cas guidé : les goûters d'un accueil de loisirs

96 enfants ; demande floue (« faire quelque chose sur les goûters ») → **diagnostic de 4 semaines** validé par le comité de pilotage. Méthodes : observation 5 mercredis, questionnaire de 10 questions (57 / 96 = **59,4 %**), entretiens, photolangage avec 8 enfants.

Résultats (n = 82 goûters) : biscuits industriels **63,4 %** ; boisson sucrée **42,7 %** ; fruit **17,1 %**. Raisons : refus des fruits 54,4 % (renforcement), pas le temps 40,4 % (facilitant), « biscuit enrichi = équilibré » 35,1 % (prédisposant), **pas de couteau ni de temps pour couper les fruits** (environnement).

Hanlon : boissons sucrées **39,7** > goûters sucrés 34,0 > peu de fruits 23,3. **Objectifs** : boisson sucrée de 42,7 % à **20 % au plus** ; fruit dans au moins **40 %** des goûters (33 sur 82). Opérationnels : fontaine à eau, atelier « fruits à croquer » 8 mercredis, document de 4 goûters à moins de 0,50 €. Leçon : l'observation a révélé une **cause organisationnelle** que personne n'avait formulée.

18. Préparer l'épreuve E5

Consigne	Attendu
« Analysez la situation »	données organisées par rubrique, **sourcées et interprétées**
« Identifiez les besoins »	classés selon **Bradshaw**, chacun appuyé par le document
« Calculez »	**formule, valeurs, résultat avec unité, phrase d'interprétation**
« Construisez l'arbre »	problème central, causes classées avec faits (« doc. 3 »), conséquences
« Hiérarchisez »	critères explicites, méthode (Hanlon), classement justifié
« Formulez les objectifs »	général, spécifiques SMART centrés public, opérationnels
« Proposez un outil de recueil »	outil, justification, questions rédigées, passation, limites

Dossier documentaire en 10 minutes : lire le sujet d'abord → noter source, date, type de chaque document → classer dans la grille → repérer les chiffres à comparer (même année, même âge) → repérer les **manques**. **Paragraphe**

d'analyse en 4 temps : **chiffre (source) → comparaison (écart, rapport) → interprétation → conséquence pour le projet**. Exemple : 38 % des CM2 sans petit-déjeuner contre 21 % : 17 points, rapport 1,81.

À l'oral, préparer une réponse courte : pourquoi cet outil ? combien de personnes, où, quand ? représentatif ? principale limite ? pourquoi ce problème ? quelle cause non retenue et qui agit dessus ? comment saurez-vous que l'objectif est atteint ? qu'avez-vous restitué ? Réponse modèle : « Pas entièrement : 48 parents à la sortie des écoles et à l'épicerie, ce qui sous-représente ceux qui travaillent tôt ; j'ai ajouté une passation le samedi et un groupe de parole ; je présente des tendances, avec les effectifs, croisées avec la PMI. »

Liens avec les autres chapitres : 2 (indicateurs, gradient) · 3 et 4 (représentations, comportements) · 5 (littératie) · 6 (consentement, RGPD) · 8 (plan d'action) · 9 (évaluation) · 16 (biais, confusion) · 17 (grandes études).

19. Fiches-outils du chapitre

Outil	Utilité
O7.1 Grille d'analyse de situation	données par rubrique, source et date, type de besoin
O7.2 Guide d'entretien (professionnel)	présentation, constats, causes, ressources, attentes, partenariat, contraintes, clôture (30 min, compte rendu anonymisé)
O7.3 Grille de prétest	questions non comprises, modalités manquantes, corrections, durée
O7.4 Grille Hanlon + PEARL	scores, PEARL, rang, justification
O7.5 Grille SMART	5 critères + indicateur et valeur initiale
O7.6 Calculateur de précision	p, 1 − p, ÷ n, √, × 1,96, intervalle

20. Chiffres et formules à savoir

Repère	Valeur
Bradshaw	**1972**, 4 besoins
Marge d'erreur	**1,96 × √(p(1 − p) / n)**
Taille d'échantillon	**385** (± 5) · 151 (± 8) · **97** (± 10)
Population finie	**n' = n / (1 + (n − 1) / N)**
Pas de sondage	**k = N / n**
Hanlon	**(A + 2B) × C / 3**, maximum 100 + **PEARL**
Groupe nominal	5-4-3-2-1, total = participants × **15** (Delbecq et Van de Ven **1971**)
Indice d'environnement	favorables / (favorables + défavorables) × 100 (mRFEI, CDC **2011**)
Hunger Vital Sign	**2 questions**, Hager **2010**
Khi-deux	seuil **3,84** (1 ddl, 5 %)
Prétest	**3 à 5** personnes du public ; questionnaire ≤ **10 min**
Groupe de parole	**6 à 10** personnes, 60 à 90 min
Accord inter-observateurs	**≥ 80 %**
Marge du rétroplanning	**≈ 20 %**
Effectifs à donner	**sous 20** répondants
Valeur cible	% × effectif, **arrondi au supérieur**
CLS	**art. L. 1434-10 CSP**, ARS + collectivité
Politiques	**PNNS 5 (2026-2030)**, **SNANC 2025-2030**
Études nationales	**INCA 3** (2014-2015), **Esteban** (2014-2016), **Albane** (résultats début 2028)
Pauvreté	seuil **60 %** du niveau de vie médian ; **15,4 %** en 2023

21. Les pièges

- **Commencer par l'action** au lieu du diagnostic.
- « De 20 % à 30 % = + 10 % » : c'est **+ 10 points**, soit **+ 50 %** en relatif.
- Besoin **exprimé** ≠ **ressenti** : l'exprimé est une **demande** (inscriptions, liste d'attente).
- Problème central = « **manque d'ateliers** » : c'est une **solution déguisée**.
- **Opportunités** = forces : non, elles sont **externes**.
- Hanlon : la **gravité compte double**, et un seul 0 au PEARL écarte le problème même avec le meilleur score.
- Objectif spécifique = ce que fait l'équipe : non, c'est **opérationnel**.
- « 60 % de 12 familles = 7 » : 7,2 → **8** (au supérieur).
- Questionnaire de **40 questions** = meilleur : non, le taux de réponse baisse.
- « 385 personnes = résultat sûr » : seulement avec un **tirage au hasard**.
- « 12 sur 20 = 60 % » : sous 20, donner d'abord **l'effectif**.
- Association dans un tableau croisé = **cause** : non, **facteur de confusion** possible.
- « 17 % des adultes **du quartier** sont obèses (Esteban) » : Esteban est **national**.
- Médiane = moyenne : non, elles diffèrent en cas de valeurs extrêmes.
- **Prétest auprès de collègues** : non, auprès du **public**.
- **Restitution à la fin** du projet : non, **avant** les priorités.
- **Camembert** pour des réponses multiples, **axe tronqué**, **3D**.
- Faire la **moyenne de codes**.
- Citer la **SNS 2018-2022**, la « CRAS » ou le « CNSP » ; écrire forces « matrices ».
- Recopier le **diagnostic local** sans recueil propre.